REPORT

특성화 실습 보고서

한·의 협진 산업 모델 및 정책적 발전 방안

2026학년도

우석대학교 한의학과

120230657 홍대진

*해당 보고서에서 언급되는 '의원/의사'는 양방 의원/의사를 의미하며 한의원/한의사는 별도로 표기했습니다

정부는 '한의약 육성법'에 근거하여 보건복지부 주도로 매 5년마다 한의약 육성발전 종합계획을 수립하고 있다. 제1차 종합계획이 국립 한의학전문대학원 설치 등 인프라 구축에 집중했고, 제3차 종합계획이 임상진료지침(CPG) 개발을 통한 진료의 표준화 및 과학화에 중점을 두었으며, 제4차 종합계획이 1차 의료와 고령화에 맞춘 '지역사회 건강돌봄'을 기조로 삼았다면, 새롭게 수립되는 제5차 종합계획(2026~2030)은 기존 돌봄 기조의 유지와 함께 'AI 및 디지털 대전환'을 핵심 축으로 삼고 있다. 특히, 한의약을 현대 보건의료 시스템에 유기적으로 통합하고, 실사용데이터(RWD)를 기반으로 한 과학적 근거를 창출하며, 한의약 산업의 글로벌 경쟁력을 극대화하는 데 방점을 두고 있다.

이러한 정책과 계획들 모두 한의사, 한의원을 방문하는 환자들 그리고 더 나아가 한의학을 위해 도움이 될 것이다. 다만 지금의 방식이 가장 효과적인가에 대해서는 이견이 있을 수도 있다. 한의학이 넘어야 할 가장 큰 장애물은 서양의학과 한의학이 법적·제도적으로 이원화된 독특한 의료 체계라고 생각한다. 한의학이 아무리 과학성을 입증하고 인공지능을 잘 활용하고 글로벌 홍보에 성공하더라도 모든 행동 하나하나에 의료계의 반발이 있는 것이 현실이다. 한의원과 일반 병의원이 의료보험이라는 하나의 파이를 두고 경쟁을 하는 상황에서 의사들에게 한의사는 본인들의 파이를 줄이는 존재로 밖에 보이지 않을 것이다. 현재에도 그들은 한의학과 양방 의학을 비전문성/전문성, 비과학적/과학적 등 다양한 프레임을 사용하며 뚜렷하게 나누려고 한다. 이러한 '프레이밍'이 계속되면 환자들도 한의학에 대한 선입견을 갖게 되고 다시 프레이밍을 강화하는 악순환이 될 것이다. 의료계의 반발에 맞서 한의학의 과학성을 입증하고 최신 기술에 빠르게 적응하는 것보다 의학과 한의학 사이의 경계를 흐릿하게 만드는 것이 먼저라고 생각한다.

제5차 종합계획의 4대 목표 중 '일차의료 강화로 한의약 접근성 제고'와 하위 추진 과제 '한-의 통합의료 기반 구축'이 있다. '중소지역기반 의원급 진료협진 모델개발'과 '병원급에서 검증된 의한 협진 표준임상경로를 의원급 맞춤형으로 재설계'에 대한 내용도 언급되었다. 이런 세부 계획도 최종적으로는 '한의학과 의학의 경계 허물기'를 목표로 한다고 생각한다. 필자는 '한-의 통합의료 기반 구축'에 대해 심화 탐구를 진행했으며 한의학연구원과 한국한의약진흥원 실무자 인터뷰를 바탕으로 가상의 산업 모델과 정책적 발전 방안을 구상해 보았다.

현재의 협진은 '의·한 협진 5단계 시범사업'이라는 이름으로 한방병원과 대형병원 차원에서 이루어지고 있다. 그 조차도 전국 104곳에 불과할 정도로 적다[1]. 중소지역의 경우 규모가 있는 의원이 한의사 혹은 의사를 고용하는 형태의 협진만 일부 존재한다. 다만 의-한 협진이 고용 형태로만 이루어진다면 일개 병·의원의 특이 케이스일 뿐 큰 시스템을 구축할 수는 없다. 결국에는 중소지역 기반 의원급 진료 협진이 이루어져야 한다. 만약 동네의 A 한의원에서 진료를 보고 추가 검진을 위해 옆 건물의 B 외과를 방문한다거나, B 외과에서 간단한 시술을 하고 이후 관리를 위해 A 한의원을 방문하는 방식이 협진이 이루어진다고 생각해보자. 환자들뿐만 아니라 필드에 있는 의사들도 한의학에 대한 거부감이 줄어들 것이다.

---

1) https://mcmc.re.kr/business/index.php

그러면 제도적인 장치와 인센티브만 마련한다면 중소지역 의원급 협진이 가능할까? 지금도 '의·한 협진'이나 '의료 회송' 등 제도적 장치들은 마련되어있다. 또 의료인에게는 경제적 인센티브, 환자에게는 의료보험 적용의 확대라는 유인책도 충분히 있다. 그럼에도 활발하게 협진이 일어나지 않는 이유는 '한의학에 대한 의학계의 부정적 인식'과 '필요성의 부재'라고 생각한다. 현재의 협진 관련 제도들은 주로 경제적인 인센티브에 초점을 맞추고 있다. 이는 '공급자에 대한 단편적인 경제적 보상 확대'나 '수요자에 대한 의료보험 적용 범위 확대'만으로 협진이 활성화될 것이라 가정하는 것으로, 실제 의료 현장에서 협진이 성립되는 복잡한 과정을 지나치게 단순화한 한계가 있다. 결국 우리가 원하는 협진, 병·의원→한의원 방향의 협진이 일어나려면 ①의사가 협진 제도에 대해 자세히 알고 있어야 하며, ②본인이 한의원과의 협진을 부정적으로 여기지 않아야 하고, ③타의료인(의학계)들이 부정적으로 바라볼 수 있다는 위험을 감당해야 하고, 그 다음에서야 ④협진으로 인한 번거로움(서류 업무)과 얻는 이득(인센티브)을 비교한 후에 선택하는 것이다. 방금 언급한 과정이 순차적으로 이루어져야 협진이 되는 것인데, ①~③의 과정은 다 무시한 채 ④번의 경제적 인센티브만 올리는 것은 아무 의미가 없다. 우리가 새로운 의-한 협진 모델을 구상한다면 인센티브가 아니라 ①~③ 과정에 영향을 줄 수 있는가를 고려해야 한다.

안정적으로 자리를 잡은 5년 차 이상의 중소지역 기반 개원의 입장에서 협진의 유인 동기를 분석해 볼 필요가 있다. 국토지리학회지에 게재된 '서울시 의원급 의료기관 생존기간 결정요인 분석(2025)' 논문에 따르면 일반 의원의 평균 수명은 60.4개월[2]로 5년 차라면 이들은 이미 안정적인 환자군을 확보한 것이다. 소규모의 보험 수가나 인센티브만을 위해 행정적 번거로움과 타 직역에 대한 심리적 장벽을 극복하고 자발적으로 협진을 채택할 유인이 절대적으로 부족하다. 중소지역기반 의원급 의-한 협진을 원한다면 우리가 노려야 할 타겟은 혼자서도 잘하고 있는, 안정적으로 자리를 잡은 의사들이 아니다. 우리가 집중해야하는 대상은 개원한지 얼마 안된, 기존 의원들과 경쟁해야 하는 절박한 신규 의사들이다. 의원의 평균 수명이 60.4개월이라는 것은 개원을 한 의사들 중 절반은 경쟁에서 밀려 5년 이내에 폐업을 선택한다는 것이다. 건강보험심사평가원에 따르면 2025년 폐업한 의원은 1011개, 신규 의원은 1840개로 전체 의원의 개수는 지난 5년간 매해 800개씩 늘어났다[3]. 이런 상황에서 신규 개원한 의사들의 가장 큰 고민은 의원의 홍보와 환자 유치일 것이다. 신규 의사들이 협진 사업을 통해 본인의 의원을 개원 초기에 안정적으로 운영할 수 있다면 한의학에 대한 부정적인 시각을 감수하고서라도 협진을 선택할 사람들이 있을 것이다. 의원급 의-한 협진 모델은 이 부분을 파고들어야 한다.

중소지역기반 의원급 의-한 협진을 한다면 우선 해당 사업에 참여하겠다는 의원과 한의원이 필요하다. 한의원은 협진 사업을 통해 의료법 상 한의원에서는 할 수 없는 의료 행위들을 협진을 통해 가능하게 하여 치료의 질 향상과 환자들이 갖고 있을만한 한의원에 대한 편견(비과학적, 비현대적, 근거 부족...등)의 해소를 기대한다. 반대로 신규 의원들이 협진 사업에 참여한다면 그들은 의원의 홍보와 환자 유치를 기대할 것이다. 의사와 한의사가 서로 바라는 바가 다르기 때문에 오히려 가능성이 있다고 생각한다. 뒷장에서부터는 새롭게 구상한 협진 사업

---

2) 이은미, 신일진, 정준호, "서울시 의원급 의료기관의 생존 기간 결정요인 분석," 국토지리학회지 제59권 4호 (2025): 403-417, https://doi.org/10.22905/kaopqj.2025.59.4.9.

3) 건강보험심사평가원 보건의료빅데이터개방시스템 "요양기관 개·폐업현황(2021~2025)"

모델에 대한 설명을 시작하겠다.

지자체 주관「지역 밀착형 한·의원급 양방향 협진 사업 모델」

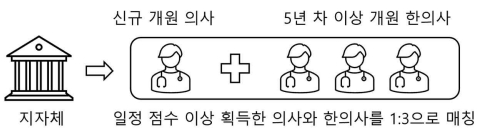
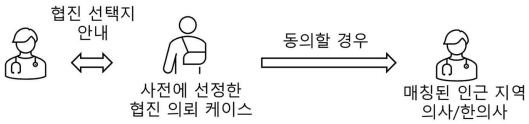
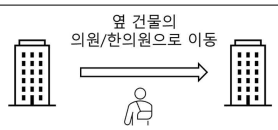
	주요 내용	핵심 세부 전략
1단계	지자체 주관 의원과 한의원 1:N 매칭	• 보건소나 지자체 주관 • 5년 이상 영업한 한의원 3곳과 신규 의원 1곳을 매칭 • 양방 검사/한방 재활 등 사전 의뢰 케이스 규정
2단계	EMR 연동 및 안전 진료	• 진료 차트 연동을 통한 진료와 처방 공유 • 양·한방 약물 상호작용 모니터링
3단계	환자의 선택권 보장 및 유도	• 거리를 기준으로 기관 목록 배치 • 재설명의 번거로움 해소
4단계	사후 관리 및 시스템 확장	• 지자체 인증 브랜드 부여로 의원의 지속적 참여 유도 • 신규 의원의 성공 모델을 통한 기존 의원의 자발적 합류(메기 효과)

1단계는 지자체나 지역 보건소 주관으로 협진 사업 참여 의원들을 짝지어 주는 것이다. 진료 과목을 고려하며 지역에서 오랫동안 영업하며 자리를 잡은 한의원과 근처에 신규 개원한 의원을 매칭시켜주는 방식이다. 예를들어 5년 이상 한 지역에서 영업한 한의원이 있다면 당연히 꾸준히 방문하는 환자들이 있을 것이다. 신규 의원은 기존의 한의원과의 협진을 통해 안정적으로 환자를 유치할 수 있다. 또 협진 의뢰 케이스를 사전에 규정한다면 진료 영역의 모호함이나 새로운 시스템이 어색해서 협진을 못하는 경우를 줄일 수 있을 것이다. 현재 진행되고 있는 '의·한 협진 5단계 시범사업' 같은 경우 협진 질병명만 정해져 있다. 의학과 한의학의 강점은 명확히 다르다. 다시 말하면 한의사는 양방 의학의 강점에 대해 잘 모르고 의사는 한의학의 강점에 대해 한의사만큼 알지 못한다. 단순히 협진 질병 항목만 정해두고 나머지는 개인의 재량에 맡기는 것으로는 부족하다. 사전에 특정 질병의 치료 영역을 어떻게 분할할지 세분화하는 작업이 이루어져야 협진이 더 활발하게 이루어진다. 필자가 말하는 '의뢰 케이스 사전 규정'은 질병 항목을 넘어 더 자세한 세부 규정을 의미한다. 그렇게 정해진 의뢰 케이스들에 한해, 의사나 한의사가 진료 후 환자에게 협진 의원에서 받을 수 있는 치료와 기대 효과를 설명해주면 된다. 설명 후 환자가 추가적인 치료나 검진, 사후 관리를 위해 협진을 원한다면 의사/한의사가 협진 의뢰서와 진료 내용을 공용 EMR에 작성하면 된다.

1단계가 원활하게 이루어지기 위해서는 몇 가지 주의 사항이 있다. 우선 협진 사업 참여시 '협진 의뢰 항목에 해당하는 환자 진료시 협진 치료에 대한 안내 진행'을 필수 조건으로 해야 한다. 그러나 이는 의료법 제27조 3항(환자 유인 및 알선 금지)에 걸릴 위험이 있기에 해당 사업은 지역 보건소 또는 지자체 주관의 공식 '의뢰, 회송 시스템'이 되어야 한다. 게다가 협진 의뢰에 대한 환자의 선택을 존중해야 하며 환자의 진료 선택권을 침해해서는 안 된다.

또 다른 문제는 협진 사업을 신규 개원한 의원과 장기간 영업한 한의원들만 골라서 진행하는 방식이다. 정부에서 진행하는 사업을 특정 의원에게만 혜택이 돌아간다면 반발이 있을 수도 있다. 이는 협진 사업 참여 의원, 한의원을 선택할 때 각각 다른 점수표를 활용해 일정 점수 이상의 업체만 참여시키면 된다. 한의원의 경우 누적 환자 수 혹은 영업일에 고점을 주어 개원한 지 몇 년 이상 된 한의원들이 자연스럽게 선정되도록 하며, 의원의 경우 양·한방 협진 교육을 몇 시간 이상 받은 의사들을 대상으로 한다는 조건을 더하면 된다. 만약 실제로 이러한 협진 모델이 실현된다면 협진 사업 안내 차원에서 전국 의대에 학생들을 대상으로 '양·한방 협진 사업 설명회'를 진행하고 해당 안내 강의를 들은 학생들은 자연스럽게 조건이 충족되게 설정하면 신규 개원의들 위주로 선정될 것이다.

마지막으로 협회측 반발의 문제가 있다. 한의사협회와 의사협회 모두의 반발이 있을 수도 있다. 한의사협회는 의사에게 유리하게 설정된 매칭 방식(1:N)을 문제 삼을 수도 있다. 이 경우 1:3 매칭 방식은 겉으로는 없애고 실제로 진행할 때 의원들에게 인근 한의원을 매칭시켜주면 된다. 애초에 의-한 협진 사업을 참여할 의원보다 한의원이 많아 비율은 따로 규정하지 않아도 1:N이 될 수밖에 없다. 만약 의사협회에서 문제를 삼는다면 의-한 협진 자체를 거부할 가능성이 높다. 그런 경우에는 처음 시행할 때에는 협진을 '의원↔한의원'의 양(兩)방향이 아니라 '한의원→의원→한의원'의 한 방향만 가능하도록 하면 된다. 이런 방식이라면 정말로 한의원 환자만 의원에 일방적으로 빼기는 것이 아닌가하는 걱정이 들 수도 있다. 하지만 환자들이 한의원을 오는 가장 큰 이유는 높은 치료 효과 때문[4]이며 이는 한의원에서 밖에 못 받는 치료 방식(침, 뜸, 부항 등...)에서 비롯되었다고 생각한다. 애초에 한의원에 오는 환자와 일반 의원에 가는 환자는 목적이 다르기에 빼기는 것을 걱정할 필요는 없다. 한의원에서 재진을 확보할 수만 있다면 협진은 '한의원 → 의원 → 한의원'의 흐름으로 이어질 수 있다. 일방향 협진이라 하더라도, 신규 양방 의원 입장에서는 환자의 초기 검사(X-ray, 혈액검사 등) 및 일반 의약품 처방을 통해 부가적인 수익을 창출할 수 있다. 더 나아가 이 과정을 통해 지역 내 잠재 환자군에게 긍정적인 진료 경험을 제공함으로써 장기적인 단골 환자를 유치하는 훌륭한 마케팅 창구가 된다. 이는 장기적으로 정책적 양방향 협진을 마련할 근거가 되며, 의원과 한의원 양측 모두에게 결코 손해가 아닌 상생 모델로 작용한다. 이상 1단계의 내용을 간단하게 정리하면 아래와 같다.

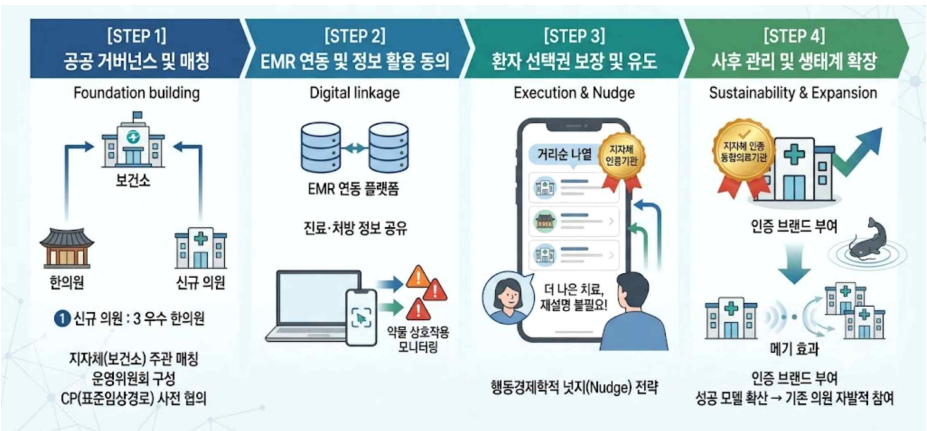
1단계	
매칭 과정	
진료 과정	
협진 과정	

4) 보건복지부, 2024년 한방의료이용 실태조사 결과

2단계는 협진에 대한 디지털 인프라 구축과 관련되어 있다. 앞서 설명한대로 환자가 협진을 원한다면 의사/한의사가 협진 의뢰서와 진료 내용을 공용 EMR에 작성하면 된다. 해당 공유 EMR은 협진을 담당하는 의원과 한의원 간에 열람이 가능하도록 구성하며, 기존 대형 한·양방 병원의 협진 데이터를 바탕으로 구축한다. 특히 양·한방 간 상이한 EMR 소프트웨어 사용으로 인한 기술적 연동 한계를 극복하기 위해, 보건복지부 주도의 '마이헬스웨이(의료데이터 국가중계 플랫폼)'를 적극 활용하거나 지자체 차원에서 표준화된 데이터 연동 API를 배포하여 시스템을 통합해야 한다. 다만, 한가지 추가한다면 현재까지 알려진 한약재 성분-일반 의약품의 교차복용 부작용 케이스들을 EMR의 Database에 저장하는 것이다. 만약 교차복용 시 부작용이 우려되는 의약품/한약이 있다면 협진 시 이를 처방하지 못하도록 시스템상 입력이 불가능하게 만드는 것이다.

3단계에서는 환자의 협진 선택 유도이다. 환자의 진료 선택권을 침해하지 않는 선에서 협진에 대해 안내해야 한다. 협진 의뢰 케이스에 해당하는 환자를 진료하게 된다면 환자의 현 상황과 협진을 통해 기대할 수 있는 치료 효과에 대한 정확한 설명이 필요하다. 또 복용 중인 한약 및 치료 이력이 EMR로 자동 연동되므로, 의원 방문 시 매번 약이나 증상을 다시 설명하는 번거로움 없이 맞춤형 연속 진료를 받으실 수 있다는 강점을 내세울 수 있다. 물론, 협진 사업 참여 조건 중에 '협진 의뢰 케이스 진료시 협진 정보 필수적으로 안내'와 같은 조항을 넣어야 할 것이다. 언어적인 부분 뿐만 아니라 병원에 협진과 관련된 공지나 팜플렛을 비치해 두는 것도 의미가 있다. 또 협진 병원들을 거리순으로 정리하여 보여주거나 '지역 우수 통합의료기관' 같은 브랜드 부여를 통해 넛지(Nudge) 효과를 기대할 수도 있다.

4단계의 핵심은 시스템 확장이다. 앞서 말한 지자체 차원의 '지역 우수 통합의료기관' 같은 브랜드 부여는 협진 사업의 이탈을 방지하는 장치 역할도 한다. 의원이 지역에 정착한 후에도 협진을 유지하도록 인증 브랜드 유지 및 협진 수가/성과금 지속 제공이 필요하다. 그리고 신규 개원의가 협진 네트워크를 통해 빠른 환자 확보 및 경영 안정을 이루면, 기존 지역 의원들도 환자 유출 방지 및 경쟁력 확보를 위해 자발적으로 협진 네트워크에 합류할 것이다. 협진 의원의 성공 사례는 지역 내 '메기 효과(Catfish Effect)'를 불러일으킬 수 있다. 게다가 보건소 중심의 일차의료 협진이 활성화됨에 따라 지역 주민의 의료 접근성 강화 및 중증 질환 예방에도 의미가 있다.



*AI로 제작된 시각자료입니다.

이상으로 제안한 「지역 밀착형 한·의원급 양방향 협진 사업 모델」은 단순한 재정적 수가 인센티브 중심의 기존 협진 정책이 가졌던 한계를 비즈니스적 접근법으로 극복하고자 하는 창의적인 시도이다. 특히, 신규 개원의의 최대 당면 과제인 '초기 환자 유치'라는 현실적 니즈를 공략하여 의료계 내부의 부정적 인식을 견디고도 참여할 만한 확실한 유인 동기를 만들어냈다는 점이 이 모델의 핵심 경쟁력이다.

1단계 매칭을 통해 지역 내 검증된 한의원들이 든든한 초기 환자 공급처 역할을 수행함으로써 신규 의원의 조기 안착을 지원하고, 사전에 합의된 특정 케이스에 대한 상호 의뢰 체계를 구축한다. 2단계 디지털 인프라 구축에서는 EMR 연계를 통해 양 기관 간 진료 정보를 실시간으로 공유함으로써, 환자가 느끼는 중복 검사의 비효율과 진료 내역 재설명의 번거로움을 근본적으로 해결한다. 이는 단순히 정보 공유를 넘어 양·한방 간 약물 상호작용 모니터링을 가능하게 하여 치료의 안전성을 높이고 환자의 신뢰를 공고히 하는 기반이 된다. 3단계 실행 과정에서는 행동경제학적 넛지(Nudge) 전략을 도입하여, 환자의 선택권을 존중하면서도 자연스럽게 협진 네트워크 내 의원으로 환자가 유입되도록 거리순 배치 및 지자체 인증 배지를 활용한다. 환자는 "이 네트워크 내 병원으로 가면 EMR 연동으로 다시 설명할 필요 없이 더 편리하고 안전한 치료를 받을 수 있다"는 확실한 가치를 체감하게 된다. 4단계 사후 관리에서는 의원이 안정화된 이후에도 협진을 지속할 수 있도록 지자체 공식 인증 브랜드 및 성과 기반 인센티브를 계속 제공하여 네트워크의 결속력을 강화한다. 이러한 신규 의원의 성공 사례는 지역 내 기존 병의원들에게 강력한 자극(메기 효과)으로 작용하여, 경쟁력 확보를 위한 자발적인 협진 생태계 참여를 유도하는 선순환 구조를 만들어낸다. 무엇보다 이 모든 과정이 지자체 주관의 공식 시범사업으로 운영됨으로써 의료법상 환자 유인 및 알선 금지 조항에 대한 법적 리스크를 원천적으로 차단한다는 점이 중요하다.

결론적으로 본 모델은 정부 주도의 하향식 수가 정책의 한계를 넘어, 의료시장 내 실제 공급자(의사, 한의사)와 수요자(환자)의 니즈를 상생과 편리성이라는 키워드로 결합해낸 현실적인 일차의료 중심 통합의료 솔루션으로 자리 잡을 것이다.